01. Anatomie et remodelage osseux

RECTO · COMPRENDRE

- Le système locomoteur comprend os, articulations, cartilage, muscles, tendons et ligaments.
- Os long : épiphyses, métaphyses, diaphyse ; os cortical et os trabéculaire.
- Ostéoblastes = formation ; ostéoclastes = résorption ; périoste = enveloppe vascularisée.
- La mobilisation et la mise en charge adaptées entretiennent le capital osseux.

01. Anatomie et remodelage osseux

VERSO · SURVEILLER / AGIR

- IDE : douleur, autonomie, peau, risque de chute et mobilisation autorisée.
- Rechercher une aggravation clinique, alerter selon l'urgence et tracer les transmissions.
- Adapter les soins aux prescriptions et aux protocoles du service.

02. Caractéristiques des fractures

RECTO · COMPRENDRE

- Fracture = rupture de continuité de l'os, complète ou incomplète.
- Décrire : siège ; trait transversal, oblique, spiroïde ; déplacement et nombre de fragments.
- Fracture ouverte = communication avec le milieu extérieur et risque d'infection.
- Fracture de fatigue = microtraumatismes répétés ; fracture de fragilité = faible énergie sur os fragilisé.

02. Caractéristiques des fractures

VERSO · SURVEILLER / AGIR

- IDE : mécanisme, douleur, déformation, peau, pouls, sensibilité et motricité.
- Rechercher une aggravation clinique, alerter selon l'urgence et tracer les transmissions.
- Adapter les soins aux prescriptions et aux protocoles du service.

03. Complications vasculaires, nerveuses et syndrome des loges

RECTO · COMPRENDRE

- Syndrome des loges : pression excessive dans la loge musculaire compromettant la perfusion.
- Alerte : douleur disproportionnée, douleur à l'étirement passif, loge tendue, paresthésies.
- Les pouls peuvent être encore présents : ne pas attendre leur disparition.
- Fracture du fémur ou bassin : risque d'hémorragie interne et de choc.

03. Complications vasculaires, nerveuses et syndrome des loges

VERSO · SURVEILLER / AGIR

- IDE : évaluer neurovasculaire, constantes, conscience ; alerte médicale immédiate.
- Rechercher une aggravation clinique, alerter selon l'urgence et tracer les transmissions.
- Adapter les soins aux prescriptions et aux protocoles du service.

04. Traitements des fractures

RECTO · COMPRENDRE

- Fonctionnel : mobilisation adaptée dans une situation retenue comme stable.
- Orthopédique : plâtre, attelle, orthèse ou corset, parfois après réduction.
- Chirurgical : ostéosynthèse par plaque, vis, clou ou fixateur externe.
- Prothèse = remplacement articulaire ; arthrodèse = fusion.

04. Traitements des fractures

VERSO · SURVEILLER / AGIR

- IDE : vérifier consignes écrites de mise en charge, restrictions, pansement et prévention thromboembolique.
- Rechercher une aggravation clinique, alerter selon l'urgence et tracer les transmissions.
- Adapter les soins aux prescriptions et aux protocoles du service.

05. Surveillances sous plâtre et fixateur

RECTO · COMPRENDRE

- Risque de compression, ischémie, œdème, plaie et lésion cutanée.
- Évaluer douleur, coloration, chaleur, pouls accessibles, perfusion, sensibilité et motricité.
- Surveiller points de pression et orifices de broches selon protocole.
- Aucun objet sous le plâtre ; garder au sec ; ne pas le modifier sans indication.

05. Surveillances sous plâtre et fixateur

VERSO · SURVEILLER / AGIR

- IDE : alerter immédiatement pour douleur croissante, paresthésie ou extrémité froide.
- Rechercher une aggravation clinique, alerter selon l'urgence et tracer les transmissions.
- Adapter les soins aux prescriptions et aux protocoles du service.

06. Fracture proximale du fémur

RECTO · COMPRENDRE

- Chez la personne âgée, souvent après chute de faible énergie.
- Douleur de hanche, impossibilité d'appui, parfois raccourcissement et rotation externe.
- Risques liés au décubitus : escarres, TVP/EP, pneumopathie, confusion et perte d'autonomie.
- Le projet de soins inclut rééducation et prévention des chutes.

06. Fracture proximale du fémur

VERSO · SURVEILLER / AGIR

- IDE : plaie, saignement, delirium, nutrition, douleur, lever prescrit et aide au domicile.
- Rechercher une aggravation clinique, alerter selon l'urgence et tracer les transmissions.
- Adapter les soins aux prescriptions et aux protocoles du service.

07. Traumatismes rachidiens

RECTO · COMPRENDRE

- Le rachis protège moelle et racines nerveuses.
- Traumatisme instable : risque de lésion neurologique lors de mobilisations inadaptées.
- Signes de gravité : déficit moteur/sensitif, troubles sphinctériens, détresse respiratoire.
- Respecter les précautions rachidiennes jusqu'à évaluation médicale.

07. Traumatismes rachidiens

VERSO · SURVEILLER / AGIR

- IDE : surveillance neurologique et ventilatoire, alignement, traçabilité.
- Rechercher une aggravation clinique, alerter selon l'urgence et tracer les transmissions.
- Adapter les soins aux prescriptions et aux protocoles du service.

08. Polytraumatisme et bassin

RECTO · COMPRENDRE

- ABCDE : voies aériennes, respiration, circulation, neurologie et exposition.
- Les fractures instables du bassin peuvent s'accompagner d'hémorragie majeure.
- Prévenir l'hypothermie et limiter les mobilisations inutiles.
- La priorité porte sur les fonctions vitales avant le traitement osseux définitif.

08. Polytraumatisme et bassin

VERSO · SURVEILLER / AGIR

- IDE : alerte, surveillance rapprochée, aide à l'hémostase et transmissions horodatées.
- Rechercher une aggravation clinique, alerter selon l'urgence et tracer les transmissions.
- Adapter les soins aux prescriptions et aux protocoles du service.

09. Lombalgie, radiculalgies, drapeaux rouges

RECTO · COMPRENDRE

- Lombalgie = douleur lombaire ; sciatique/cruralgie = irradiation radiculaire.
- Pour une lombalgie commune : éviter le repos strict prolongé et favoriser la reprise progressive.
- Alerte : anesthésie en selle, troubles sphinctériens récents, déficit progressif, fièvre ou contexte tumoral.
- Prévention : gestes adaptés et aides techniques en manutention.

09. Lombalgie, radiculalgies, drapeaux rouges

VERSO · SURVEILLER / AGIR

- IDE : interroger élimination, déficit neurologique et retentissement fonctionnel.
- Rechercher une aggravation clinique, alerter selon l'urgence et tracer les transmissions.
- Adapter les soins aux prescriptions et aux protocoles du service.

10. Ostéoporose et fractures de fragilité

RECTO · COMPRENDRE

- Ostéoporose = perte de résistance osseuse et fractures après faible traumatisme.
- Localisations classiques : vertèbres, poignet et extrémité supérieure du fémur.
- DXA mesure la densité minérale ; le T-score ne remplace pas l'évaluation globale.
- Prévention : activité adaptée, équilibre, nutrition, réduction des chutes, médicaments selon prescription.

10. Ostéoporose et fractures de fragilité

VERSO · SURVEILLER / AGIR

- IDE : repérer fracture antérieure, risque de chute et observance du suivi.
- Rechercher une aggravation clinique, alerter selon l'urgence et tracer les transmissions.
- Adapter les soins aux prescriptions et aux protocoles du service.